Caderno de Bolso

CTI

Téc. Enfermagem

NAVEGAÇÃO

Índice de consulta

Assunto	Páginas
Plantão, referências e gasometria	3 a 6
Ventilação e via aérea	7 a 9
EVA, BPS, PAINAD e CPOT	10 a 16
RASS, Glasgow e delirium	17 a 21
Dispositivos e cuidados	22 a 27
Medicações e bombas	28 a 33
Cálculos rápidos	34 e 35
Deterioração, sepse e PCR	36 e 37
Registros, plantão e transporte	38 a 40
Fontes e bulas de consulta	41 a 44
Modelo básico de evolução	45 e 46
Folhas de horários	47 a 96

Síntese dos materiais de CTI e do modelo enviado. Casos didáticos.

Imprima em 100%. A4: frente única, 1 página do PDF por folha. Recorte e organize pela numeração.

Resumo para estudo e consulta

ROTINA E MONITORIZAÇÃO

Ao assumir o plantão

Antes dos cuidados

1. Confira dois identificadores, alergias, precauções e motivo da internação.
2. Receba as metas de PAM, SpO2, sedação, glicemia e balanço, quando definidas.
3. Compare consciência, dor, respiração, perfusão e diurese com o turno anterior.

Leia o leito

Via aérea e ventilador → monitor → bombas → acessos → sondas e drenos → dieta → pele. Rastreie cada infusão até o paciente.

Organize o turno

Confira horários de medicações, cuidados prescritos, exames, pendências e risco de deterioração. Ao sair do box, cheque conexões, alarmes, posição e segurança.

Fontes: [1], [2], [13], [14]

ROTINA E MONITORIZAÇÃO

Referências e metas

Valores de referência ajudam no estudo. No paciente crítico, acompanhe a **meta individual e a tendência**.

Parâmetro	Leitura de bolso
FC	60 a 100 bpm: referência em repouso.
FR	12 a 20 irpm: referência em repouso.
SpO2	Meta individual; conferir sensor e curva.
PAM	Meta prescrita e sinais de perfusão.
Temperatura	Método/local e tendência.
Diurese	Volume, período e mL/kg/h.

Resultado inesperado: avalie o paciente, confirme a medida e comunique a mudança. Gasometria na página 6; diurese na página 23.

Fontes: [10], [11], [12]

ROTINA E MONITORIZAÇÃO

Perfusão e pressão

Observe em conjunto

PA/PAM, pulso e ritmo, consciência, temperatura/cor das extremidades, enchimento capilar e diurese. Um número isolado não define perfusão.

PNI e PAI

PNI: manguito adequado, posição e repetição conforme rotina.
PAI: curva, conexões, sítio, perfusão distal e transdutor no nível/zero orientados pelo protocolo.

Bolhas, dobras, posição e amortecimento podem distorcer a PAI. Compare leitura, curva e condição do paciente.

Mudança importante

PAM baixa com hipoperfusão, sangramento ou DVA interrompida: avaliação imediata. A linha arterial não é via de medicamentos.

Fontes: [10], [13]

RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Gasometria arterial

Dado	Referência didática
pH	7,35 a 7,45
PaCO2	35 a 45 mmHg
HCO3-	22 a 26 mEq/L

Sequência de leitura

pH → PaCO2 → HCO3- → compensação → oxigenação → contexto. Compare com a faixa do laboratório.

Padrão simples	Sugere componente
pH ↓ + PaCO2 ↑	Respiratório acidótico.
pH ↓ + HCO3- ↓	Metabólico acidótico.
pH ↑ + PaCO2 ↓	Respiratório alcalótico.
pH ↑ + HCO3- ↑	Metabólico alcalótico.

PaO2 depende de idade, altitude e FiO2. Compensações e distúrbios mistos exigem análise completa. Esses padrões orientam estudo e comunicação.

Fontes: [12]

RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Ventilação mecânica

Sigla	Significado
FiO2	Fração inspirada de oxigênio.
PEEP	Pressão positiva ao final da expiração.
Vt / VC	Volume corrente por ciclo.
VE	Volume ventilado por minuto.
Ppico	Pressão inspiratória de pico.
Pplat	Pressão de platô.
PCV / VCV	Controle a pressão / a volume.
PSV	Pressão de suporte.

Leia no leito: modo, FiO2, PEEP, frequência, volumes, pressões, SpO2, conforto e sincronia. Diferencie o valor programado do valor medido.

A programação e as mudanças de suporte seguem a equipe responsável, a prescrição e o protocolo.

Fontes: [14]

RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Via aérea e alarmes

TOT/TQT: confira fixação, marca/posição registrada, pele, secreções e conexões. Mudança de marca exige avaliação.

Alarme	O que conferir
Alta pressão	Paciente, tosse, secreções, dobra/água no circuito e possível obstrução.
Baixa pressão ou volume	Desconexão, fuga, circuito e deslocamento da via aérea.
SpO2 caiu	Paciente, esforço, sensor/curva, oferta de O2, via aérea e circuito.

Resposta inicial

Avalie o paciente e chame ajuda se houver deterioração. Identifique a causa do alarme; evite apenas silenciá-lo.

Extubação, obstrução ou falha ventilatória: ajuda imediata. Não avance o TOT por decisão própria.

Fontes: [14], [17]

PAV e secreções

Cuidados do dia a dia

Higienize as mãos; mantenha o circuito íntegro; faça higiene oral conforme o POP. Cabeceira de **30 a 45°** quando indicada e sem contraindicação.

Cheque o cuff pelo método, atribuição e faixa do setor. Evite que o condensado do circuito alcance o paciente. Confira o conjunto de medidas de prevenção.

Aspiração de vias aéreas

Secreções, sinais de obstrução ou piora ventilatória precisam de avaliação. Prepare material e monitorização e comunique o enfermeiro.

Na equipe de enfermagem, a aspiração de pacientes graves com TOT/TQT é privativa do enfermeiro, conforme Cofen 557/2017. No estágio, acompanhe e auxilie dentro da orientação recebida.

Fontes: [14], [17]

Escolha da escala

Tente o **autorrelato confiável** primeiro. A intubação, por si só, não o impede.

Situação	Instrumento
Compreende e marca a linha	EVA, conforme o protocolo.
Intubado, sem autorrelato	BPS ou CPOT, com respostas observáveis.
Demência avançada	PAINAD se o autorrelato não for confiável e o perfil for adequado.

EVA

Use o formulário com linha contínua de **10 cm, sem números**. O paciente marca a dor atual; meça a distância a partir da extremidade sem dor.

Marca a 60 mm em 100 mm = **EVA 60/100 mm**, ou 6/10 conforme o formulário. Use a linha de tamanho correto; esta página descreve a aplicação.

Fontes: [3], [5], [7]

BPS indicação e face

Behavioral Pain Scale: adulto crítico intubado, sem autorrelato confiável e com comportamentos observáveis.

São três domínios, de **1 a 4** pontos cada. Total de **3 a 12**. Observe um contexto definido e some os três itens.

Expressão facial

Pts	Critério resumido
1	Face sem tensão.
2	Tensão parcial, como sobrancelhas contraídas.
3	Tensão de toda a face, como olhos fechados.
4	Careta com contração acentuada.

Complete com membros e ventilação na página 12. **BPS 3 é o mínimo**; isoladamente, não comprova ausência de dor.

Fontes: [3], [4]

BPS membros e VM

Membros superiores

Pts	Critério resumido
1	Sem movimentação.
2	Flexão parcial.
3	Flexão completa de membros e dedos.
4	Retração contínua; membros contraídos.

Adaptação à ventilação

Pts	Critério resumido
1	Tolera ventilação e movimentos.
2	Tosse durante os movimentos.
3	Luta contra o ventilador.
4	Ventilação não controlável pelo padrão observado.

Exemplo: 2 + 2 + 2 = BPS 6/12. Registre contexto e achados. Tosse/dessincronia também exigem avaliação respiratória.

Fontes: [3], [4]

PAINAD respiração e voz

Para demência avançada sem autorrelato confiável. São **cinco domínios de 0 a 2**; total 0 a 10. Tente comunicação acessível primeiro.

Pts	Respiração independente da voz
0	Normal.
1	Dificuldade eventual ou hiperventilação breve.
2	Difícil e ruidosa; hiperventilação prolongada ou Cheyne-Stokes.
Pts	**Vocalização negativa**
0	Ausente.
1	Gemido eventual ou fala baixa de desagrado.
2	Chamados repetidos em sofrimento; gemidos altos, gritos ou choro.

Complete na página 14. Confira o perfil: PAINAD não substitui automaticamente BPS/CPOT no paciente sedado em VM.

Fontes: [5]

PAINAD face e corpo

Pts	Expressão facial
0	Sorri ou sem expressão.
1	Tristeza, medo ou sobrancelhas contraídas.
2	Careta.
Pts	**Linguagem corporal**
0	Corpo relaxado.
1	Tensão, inquietação ou agitação aflita.
2	Rigidez; punhos fechados; joelhos dobrados; resistência ao cuidado ou agressividade.
Pts	**Consolabilidade**
0	Não precisa de consolo.
1	Acalma ou se distrai com voz/toque.
2	Permanece inconsolável.

Some também respiração e voz. PAINAD 5/10 não equivale automaticamente a EVA 5/10.

Fontes: [5]

CPOT e limitações

Critical Care Pain Observation Tool: ferramenta comportamental quando o adulto crítico não consegue autorrelatar e as respostas podem ser observadas.

Domínios	Pontuação
Face	0 a 2
Movimentos corporais	0 a 2
Tensão muscular	0 a 2
Ventilação OU vocalização	0 a 2

Total: 0 a 8. Ventilação se intubado; vocalização se não intubado. Apenas um desses itens entra na soma. Consulte critérios e técnica do formulário oficial.

Limitação a registrar

Sedação profunda, bloqueio muscular e lesões neurológicas podem impedir observar respostas. Imobilidade não comprova ausência de dor.

Fontes: [3], [6]

Registro e reavaliação

Cinco campos

Horário → instrumento/escore → contexto e achados → comunicação/ação → resposta posterior e horário.

Exemplo fictício

08h10: marca EVA 60/100 mm em repouso; dor lombar. Enfermeira informada. Reposicionamento conforme orientação.
08h30: marca EVA 30/100 mm em repouso e refere maior conforto.

Na nova avaliação

Use o mesmo instrumento se adequado. Se a comunicação ou o perfil mudarem, registre a razão da nova escolha.

Reavalie no intervalo indicado para o cuidado, o medicamento e o protocolo. Os horários acima ilustram um registro; não definem um intervalo universal.

Fontes: [1], [3], [7]

RASS agitação

Richmond Agitation Sedation Scale: agitação e despertar. Varia de +4 a -5. Dor e delirium precisam de avaliações próprias.

Pts	Resposta resumida
+4	Combativo: comportamento violento com risco imediato.
+3	Muito agitado: tenta retirar dispositivos ou agride.
+2	Agitado: movimentos frequentes sem finalidade; luta contra o ventilador.
+1	Inquieto/ansioso, sem movimento vigoroso ou agressivo.
0	Alerta e calmo.

Comece observando o paciente. Registre o comportamento encontrado e compare com a meta de sedação. Resultados negativos e sequência na página 18.

Fontes: [8]

RASS sedação

Pts	Resposta resumida
-1	Desperta à voz e mantém contato visual por mais de 10 s.
-2	Desperta à voz com contato visual por menos de 10 s.
-3	Movimenta-se ou abre olhos à voz, sem contato visual.
-4	Não responde à voz; responde ao estímulo físico.
-5	Sem resposta à voz nem ao estímulo físico.

Sequência

Observe → chame pelo nome e peça para abrir os olhos/olhar → sem resposta à voz, etapa física conforme treinamento e supervisão.

Exemplo: contato visual por 5 s = RASS -2. Compare com a meta; registre interferências. Não suspenda sedação apenas para testar.

Fontes: [3], [8]

Glasgow ocular e verbal

Respostas ocular **O**, verbal **V** e motora **M**. Soma 3 a 15, com todos os componentes testáveis.

Pts	Abertura ocular
4	Espontânea.
3	À solicitação sonora.
2	À pressão apropriada.
1	Ausente, sem impedimento ao teste.
Pts	**Resposta verbal**
5	Orientado: pessoa, lugar e tempo.
4	Conversa, mas está desorientado.
3	Palavras reconhecíveis, sem conversa adequada.
2	Sons incompreensíveis.
1	Ausente, sem impedimento ao teste.

Motora e limitações na página 20. Estímulos exigem treinamento.

Fontes: [9]

Glasgow motora e NT

Pts	Melhor resposta motora
6	Obedece a uma ordem.
5	Localiza e tenta remover o estímulo.
4	Flexão de retirada normal.
3	Flexão anormal.
2	Extensão anormal.
1	Ausente, sem impedimento ao teste.

Quando não é testável

Intubação pode impedir resposta verbal. Ex.: **O3 VNT M6, intubado**. Registre NT e o motivo; evite apresentar uma soma como total completo.

Sedação, bloqueio muscular, idioma, audição e limitações físicas interferem. Pupilas são registradas à parte.

Exemplo testável: O3 + V4 + M6 = Glasgow 13/15. Descreva as respostas.

Fontes: [9]

Delirium e alerta neuro

CAM-ICU em visão geral

Use formulário validado e treinamento. O algoritmo verifica:

1. Mudança aguda ou curso flutuante.
2. Desatenção.
3. Nível de consciência alterado.
4. Pensamento desorganizado.

Positivo: **1 + 2, com 3 ou 4**.
RASS -4/-5: não suficientemente desperto para o teste; registre **não avaliável**.

Mudança neurológica

Compare com o basal e informe horário, respostas novas, pupilas e interferências. Convulsão, nova anisocoria, déficit focal ou rebaixamento súbito exigem avaliação imediata.

Orientação, sono, recursos auditivos/visuais e mobilização seguem o plano de cuidado.

Fontes: [3], [8], [9]

Acessos venosos

AVP CVC PICC

Confira sítio, fixação, curativo, identificação dos lúmens, conexões, permeabilidade e infusões. Rastreie cada linha até o paciente.

Observe dor, edema, hiperemia, calor, secreção, sangramento ou deslocamento. AVP infiltrado/extravasado e acesso perdido com DVA exigem ação imediata da equipe.

Prevenção de infecção

Higienize as mãos e desinfete conexões pelo método do setor. Curativo úmido, sujo ou solto precisa de avaliação e troca conforme protocolo.

Preserve sistema e técnica asséptica. Evite desconexões desnecessárias e não force infusão ou flush diante de resistência. Confira compatibilidade e indicação de via exclusiva.

Fontes: [2], [13]

SVD e diurese

Cheque o sistema

Sistema fechado; fixação; tubo sem dobra/compressão; fluxo livre; bolsa abaixo da bexiga e fora do chão. Higiene conforme protocolo.

Registre **volume, aspecto e período**. Alteração aguda da diurese exige comunicação; confira também PA/perfusão e o contexto.

Cálculo

mL/kg/h = volume ÷ peso ÷ horas.
240 mL ÷ 80 kg ÷ 6 h = **0,5 mL/kg/h**.

KDIGO: diurese **<0,5 mL/kg/h por pelo menos 6 h** é critério de lesão renal aguda. Esse intervalo é diagnóstico; não espere 6 h para comunicar queda importante.

Para cultura, utilize o ponto de coleta e técnica indicados pelo protocolo; a bolsa não é o local de coleta de urocultura.

Fontes: [11], [13]

Balanço e função renal

BH do período

Entradas - saídas.
Registre o volume realmente recebido ou eliminado e o horário.

Entradas	Saídas
Infusões, soluções, dieta, água e sangue conforme rotina.	Urina, drenos, vômitos e outras perdas mensuradas.

Exemplo: 2.100 - 1.600 = **+500 mL**. O resultado mostra diferença de volumes registrados; não define volemia sozinho.

Diálise e terapias renais

Confira modalidade, acesso e registro da ultrafiltração. Evite duplicar essa perda no BH. Vigie PA, acesso, sangramento e alterações do período.

A interpretação combina creatinina, eletrólitos, peso, balanço, perfusão e evolução clínica.

Fontes: [11]

Sondas e dieta enteral

Antes de usar

Confira paciente, prescrição, tipo de sonda, fixação, marca externa e confirmação de posição pelo método institucional. Identifique o circuito enteral.

A ausculta após injetar ar, isoladamente, não confirma posicionamento seguro. Mudança de marca, vômitos ou suspeita de deslocamento exigem avaliação antes do uso.

Durante a dieta

Observe velocidade/volume, posição prescrita, distensão, vômitos, evacuações e tolerância. Registre interrupções e o motivo.

Medicação pela sonda

Confira via, forma e lavagem da sonda. Não triture liberação modificada ou revestimento especial sem orientação farmacêutica.

Fontes: [2], [14]

Drenos e ostomias

Identifique o dispositivo

Tipo, localização, fixação, sistema, volume e aspecto. Compare com o débito anterior e mantenha a posição orientada.

Dreno torácico: preserve o sistema e o selo d’água quando aplicável; observe conexões, oscilação e borbulhamento conforme o tipo. Não clampeie nem ordenhe rotineiramente.

DVE: nível, referência e manejo são definidos pela equipe. Movimentação/transporte exigem planejamento; não altere altura ou clamp por decisão própria.

Ostomias e sinais de alerta

Observe cor do estoma, pele, efluente e adaptação. Sangue vivo aumentado, cessação inesperada, desconexão, dor, estoma pálido/escuro ou piora clínica precisam de avaliação.

Fontes: [1], [13]

Pele, higiene e posição

Durante cada cuidado

Inspecione sacro, calcâneos, occipital, proeminências e áreas sob dispositivos. Observe hiperemia persistente, umidade, lesões e pontos de pressão.

A avaliação de risco, como Braden quando adotada, complementa a inspeção. Reposicionamento e superfícies de apoio seguem risco e tolerância individual.

Planeje a mobilização

Confira dor, via aérea, acessos, drenos, bombas e estabilidade com a equipe. Preserve conforto, privacidade e temperatura. Interrompa se houver deterioração.

Na pronação

Manobra de equipe: proteja via aérea, olhos, pele e dispositivos; confira tudo após a virada. Siga o plano prescrito.

Fontes: [14], [15]

Medicação e bombas

Conferência antes de administrar

Paciente, medicamento, dose, via, horário, forma, ação/indicação, registro e resposta. Confirme alergias e esclareça dúvidas antes de administrar.

Infusão contínua

Droga → concentração → unidade → velocidade → volume → linha → acesso. Compare rótulo, prescrição e tela; não deduza pela posição da bomba.

Unidades diferem: **mcg/kg/min, mcg/min, mg/h e mL/h**. Faça a dupla checagem quando prevista.

Se a bomba alarmar

Identifique a terapia e avalie o paciente. Confira acesso, oclusão, conexões e volume. DVA interrompida, extravasamento ou erro exigem comunicação imediata.

Fontes: [2], [18]

Drogas vasoativas

Droga	Uso e vigilância
Noradrenalina	Vasopressor. PAM, ritmo, perfusão e acesso.
Vasopressina	Vasoconstritor, adjuvante em cenários selecionados. PA e sinais de isquemia.
Dobutamina	Inotrópico. Ritmo, FC, PA e resposta de perfusão.

Conferência de bolso

Nome, concentração, unidade, bomba, via/lúmen e meta. Observe extremidades, sítio e tendência hemodinâmica.

Interrupção ou extravasamento de noradrenalina pode causar deterioração e lesão tecidual. Acione a equipe prontamente.

Via, diluição e titulação seguem prescrição, protocolo e atribuições profissionais. Diluições variam entre produtos e serviços.

Fontes: [2], [10], [18]

Sedação e analgesia

Exemplo	O que observar
Propofol	Sedação; PA, FC e ventilação. Pode provocar hipotensão/apneia.
Midazolam	Sedação; vigie consciência e respiração. Maior risco com opioides.
Dexmedetomidina	Sedação; FC e PA. Atenção a bradicardia e hipotensão.
Fentanil	Analgesia; dor, sedação, respiração e PA. Risco de depressão respiratória.

Compare RASS e dor com as metas. Mudança inesperada exige avaliação da infusão, da via aérea e do paciente.

Fontes: [3], [18]

Bloqueio neuromuscular

Exemplo: **rocurônio**. O bloqueador produz paralisia muscular, **sem substituir sedação e analgesia**.

O que acompanhar

Suporte ventilatório, infusões prescritas, monitorização definida pela equipe, proteção ocular, pele e posicionamento.

Confira medicamento, concentração, unidade, bomba, acesso e continuidade das terapias. Imobilidade não demonstra conforto nem ausência de consciência.

Avaliação da dor

Respostas comportamentais podem não ser observáveis. Registre o impedimento e comunique a necessidade de avaliação; não conclua ausência de dor porque o paciente não se movimenta.

Fontes: [3], [18]

Glicemia e insulina

Antes de administrar

Confira tipo de insulina, concentração, dose, via, horário e bomba quando utilizada. Verifique a prescrição e a dupla checagem prevista.

Durante o tratamento

Acompanhe a glicemia na frequência prescrita e sua relação com dieta/infusões. Interrupção de dieta precisa de comunicação e revisão das orientações.

Hipoglicemia pode causar sudorese, tremor, confusão ou rebaixamento; sedação pode mascarar sintomas. Insulina também pode reduzir o potássio.

Se houver alteração

Comunique prontamente, siga o protocolo de correção e reavalie glicemia e resposta no intervalo definido. Registre horário, valor, ação e resultado.

Fontes: [2], [18]

MEDICAÇÕES E INFUSÕES

Eletrólitos e antimicrobianos

Eletrólitos

KCl concentrado nunca é IV direto. Requer diluição e velocidade prescritas. Confira função renal, acesso e monitorização indicada.

Alterações de K, Mg, Ca e Na podem acompanhar arritmias, fraqueza, convulsão ou rebaixamento. Valores críticos e sintomas exigem comunicação rápida.

Antimicrobianos

Respeite horários, alergias, diluição, tempo de infusão e compatibilidade. Coletas prescritas devem seguir o protocolo sem atrasar tratamento crítico.

Fontes: [2], [10], [18]

CÁLCULOS RÁPIDOS

Cálculos volume e tempo

Balanço e diurese

BH = entradas - saídas.
2.100 - 1.600 = +500 mL.
Diurese = mL ÷ kg ÷ horas.
240 ÷ 80 ÷ 6 = 0,5 mL/kg/h.

Infusão

mL/h = volume ÷ horas.
500 mL ÷ 4 h = 125 mL/h.
Volume = mL/h × horas.
25 mL/h × 8 h = 200 mL.

PAM aproximada

(PAS + 2 × PAD) ÷ 3.
PA 120/60: (120 + 120) ÷ 3 = aproximadamente 80 mmHg.

A PAM calculada é uma aproximação. Em PAI com sinal adequado, utilize a leitura monitorizada conforme a rotina.

Fontes: [2], [10], [11]

CÁLCULOS RÁPIDOS

Cálculos dose e unidade

Conversões

1 g = 1.000 mg
1 mg = 1.000 mcg
1 L = 1.000 mL

Dose para volume

mL = dose prescrita ÷ concentração.
Exemplo didático: 250 mg prescritos; solução 50 mg/mL → **5 mL**.

Concentração final

mg/mL = quantidade de mg ÷ volume final. Confira o volume final do preparo.

Para soluções em **% massa/volume**: 1% = 10 mg/mL; 2% = 20 mg/mL; 0,9% = 9 mg/mL. Confira o tipo de porcentagem no rótulo.

Unidades devem ser compatíveis. Exemplos não definem doses, diluições, vias ou velocidades de medicamentos reais.

Fontes: [2]

INTERCORRÊNCIAS

Deterioração e sepse

Mudança que exige avaliação

Hipotensão com hipoperfusão; maior necessidade de O2; nova confusão/rebaixamento; queda da diurese; pele fria/moteada; sangramento ou infusão crítica interrompida.

Em infecção suspeita/confirmada, essas mudanças podem acompanhar sepse. Ausência de febre não a exclui. Lactato é interpretado com contexto e evolução.

Como responder

Paciente → ajuda → via aérea, respiração e circulação → conferência de medidas/dispositivos → ações previstas → reavaliação e registro.

SSC 2026: alvo inicial de PAM de **65 mmHg** no choque séptico; para adultos ≥65 anos, sugere faixa inicial **60 a 65**. A equipe define a meta do paciente.

Fontes: [10], [16]

INTERCORRÊNCIAS

PCR no adulto

Sem resposta, sem respiração normal e sem pulso definido em até **10 s**: acione a resposta de emergência, peça desfibrilador e inicie RCP conforme treinamento.

Compressões de qualidade

100 a 120/min; profundidade de pelo menos 5 cm, evitando mais de 6 cm; retorno completo do tórax e poucas interrupções.

Sem via aérea avançada: **30:2**.
Com via aérea avançada: compressões contínuas e **1 ventilação a cada 6 s**, conforme a equipe. Evite hiperventilação.

Ritmo na PCR	Categoria
FV / TV sem pulso	Chocável.
AESP / assistolia	Não chocável.

Desfibrilação e demais medidas seguem equipamento, treinamento e algoritmo institucional. O monitor isolado não confirma presença ou ausência de pulso.

Fontes: [16]

REGISTROS E COMUNICAÇÃO

Anotação de enfermagem

Dados que tornam o cuidado claro

Horário, avaliação objetiva, contexto, cuidado executado, comunicação e resposta. Informe instrumento/escore e suporte quando relevantes.

Exemplo fictício

09h00: em VMI por TOT, SpO2 95% com FiO2 40%, RASS -2. BPS 6/12 durante mudança de decúbito: face 2, membros 2, ventilação 2. Enfermeira informada. Reposicionamento conforme orientação. Às 09h20, em repouso, BPS 3/12.

O exemplo descreve pontuação e contexto, sem concluir ausência de dor pelo escore mínimo. Os horários são ilustrativos.

Registre apenas o que avaliou/executou. Use siglas padronizadas e identificação exigida. A checagem da medicação complementa, mas não substitui, a anotação pertinente.

Fontes: [1], [2], [4]

REGISTROS E COMUNICAÇÃO

Passagem de plantão

Roteiro para falar

1. Motivo do CTI e eventos do turno.
2. Consciência, dor e sedação.
3. Via aérea, suporte e SpO2.
4. Ritmo, PAM/perfusão e DVA.
5. Acessos, sondas e drenos.
6. Dieta, diurese e BH.
7. Pele, precauções e riscos.
8. Metas, horários e pendências.

SBAR diante de uma mudança

S: situação/problema atual.
B: contexto e antecedentes úteis.
A: dados observados e tendência.
R: avaliação/ajuda necessária e pendências.

Ex.: “A PAM caiu abaixo da meta e a diurese reduziu. Usa noradrenalina; bomba e linha conferidas. Preciso de avaliação no leito.” Acrescente valores e horários reais.

Fontes: [1], [10]

REGISTROS E COMUNICAÇÃO

Transporte e saída do box

Antes do transporte

Planeje com a equipe: destino, monitor, O2/ventilação, bombas, bateria, medicamentos, acessos e material para intercorrências.

Confirme o suporte durante todo o trajeto e a fixação de via aérea, linhas, sondas e drenos. Leve as informações necessárias.

Ao terminar qualquer cuidado

Paciente posicionado e protegido → O2/VM conectados → bombas funcionando → linhas sem tração → bolsas e drenos adequados → alarmes ativos → registros e pendências comunicados.

Higienize as mãos. Use precauções padrão e os EPIs/medidas adicionais de contato, gotículas ou aerossóis conforme o setor e a exposição.

Fontes: [1], [2], [13], [14]

REFERÊNCIAS

Fontes de dor e prática

[1] Cofen. Resolução 736/2024. Processo de Enfermagem e registros.
Abrir resolução

[2] MS/Anvisa. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 2013.
Abrir protocolo

[3] Devlin et al. SCCM PADIS. Dor, sedação e delirium. 2018.
Abrir diretriz

[4] Morete et al. BPS-Brasil. RBTI. 2014;26:373-378.
Artigo e critérios

[5] Pinto et al. PAINAD-Brasil. Einstein. 2015;13:14-19.
Artigo e critérios

[6] Ministry of Health Malaysia. Pain Management Handbook. 3ª ed. 2023. CPOT.
Abrir manual

REFERÊNCIAS

Fontes de neuro e clínica

[7] ReBEC. RBR-86my7w2. Mensuração da EVA em linha de 10 cm.
Abrir descrição

[8] Vanderbilt/CIBS. RASS e CAM-ICU. Recursos oficiais em português.
Abrir materiais

[9] Glasgow Coma Scale. Guia brasileiro e limitações de avaliação.
Guia | Impedimentos

[10] Prescott et al. SCCM. Surviving Sepsis Campaign em adultos. 2026.
Abrir diretriz

[11] KDIGO. Acute Kidney Injury. 2012. Critérios de LRA e diurese.
Abrir diretriz

[12] Cleveland Clinic. Arterial Blood Gas. Valores de gasometria.
Abrir referência

REFERÊNCIAS

Fontes de cuidados e PCR

[13] CDC. Prevenção de infecção em cateter vascular e cateter urinário. Resumos 2024.
Cateter vascular | Cateter urinário

[14] Anvisa. Protocolo de prevenção de PAV. Versão 1; disponibilizado em 2026.
Abrir protocolo

[15] Anvisa. Nota Técnica 05/2023. Prevenção de lesão por pressão.
Abrir nota

[16] AHA. Adult Basic Life Support. Diretrizes de RCP 2025.
Abrir diretriz

[17] Cofen. Resolução 557/2017. Aspiração de vias aéreas.
Abrir resolução

REFERÊNCIAS

Bulas para consulta

[18] NLM/DailyMed. Informações oficiais de produtos consultadas para usos e riscos farmacológicos.

Noradrenalina — abrir rótulo
Propofol — abrir rótulo
Midazolam — abrir rótulo
Dexmedetomidina — abrir rótulo
Fentanil — abrir rótulo
Rocurônio — abrir rótulo
Insulina humana IV — abrir rótulo
KCl concentrado — abrir rótulo

Esses rótulos são referências farmacológicas dos EUA. No preparo, use a bula do produto disponível no setor, a prescrição e o protocolo institucional.

Fontes consultadas em 05/10/2026. Quadros de escalas são sínteses didáticas; mantenha os formulários validados do serviço à mão. O material não representa protocolo oficial do HMV.

Modelo básico de evolução, estrutura:

"SETOR ATUAL DO PACIENTE E TURNO"

00:00 - assumo paciente Sr/Sra ..., 00 anos;

- avalio na escala de dor (selecione), RASS (selecione);
- como o paciente está ventilando?
- como o paciente está se alimentando?
- quais os acessos desse paciente? (especificar caso esteja infundindo algum medicamento)
- como são as eliminações desse paciente?
- já visualizou o dorso do paciente?
- como estão a extremidades do paciente?

OBS: sempre seguir esta ordem CEFALO - CAUDAL, se necessário adicionar particularidades, como drenos, sondas ou cutativos (F.O).

Exemplo de uma evolução estruturada e pronta:

CTI adulto - área 3, manhã.

7:00 - assumo paciente Sr. João, 80 anos;

- avalio na escala de dor PAINAD 0, RASS 0;
- ventilando com auxílio de óculos nasal O^2 à 2L/min;
- dieta vo pastosa;
- PICC em MSD infundindo SF 0,9% à 50ml/h;
- F.O em flanco direito, curativo seco e limpo;
- CVD + fralda;
- não visualizo dorso no momento;
- extremidades frias, mas perfundidas.

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações:

Nome:
Leito:

07:00:

08:00:

09:00:

10:00:

11:00:

12:00:

13:00:

Observações: